

医療 AI の実態 2026

光と影を踏まえて、使いこなすために

Doximity（米国医師向けプラットフォーム）8万人 + AMA（米国医師会）1,300人 調査から読む

研修医・専攻医向け 30分 | 2026-03-24

数字が語る現実

94%

医師が AI 利用中
または検討中

Doximity 2026

81%

AI 利用率
(2023 年 38% から倍
増)

AMA 2025

2 時間

1 日あたりの
時短効果

アンビエント AI

#1

家庭医が
AI 最頻度ユーザー

Doximity 2026

「AI は使えるのか？」のフェーズは終わった。問題は「どう安全に使うか」。

医師は何に AI を使っているのか

用途	割合	具体例
臨床ドキュメント作成	最多	Nuance DAX, Abridge, Suki
「パジャマタイム」解消	主目的	勤務外の事務作業を削減
診断支援	少ない	OpenEvidence 等
患者対応・ケア	非常に少ない	今後の拡大領域

「パジャマタイム」 = 勤務後にパジャマでカルテを書く時間。
AI が解消してくれるのは、「診断」ではなく「事務」。

光の側

OpenEvidence

日 100 万件

査読済み文献ベースの
臨床意思決定支援

AI 研修 RCT

保持率 91%

AI が研修医教育の
質を向上させる

Mount Sinai

コスト 65 分の

マルチエージェント AI が
1
単独より優秀

影の側

ECRI 患者安全

AI 診断が #1

ECRI = Emergency Care
Research
Institute (米国医療安全研究機構)
自動化バイアスが誤診リスクを増大

スタンフォード

半数が試験で評価

実患者データは
わずか 5%

AMA 倫理

監視の空洞

AMA = American Medical
Association
(米国医師会)
倫理ジャーナル廃刊 x AI センター設
立

国家レベルの応答

NAM = National Academy of Medicine (米国医学アカデミー)

「AI時代の患者安全」イニシアチブ -- 2026年3月発足

Mayo Clinic CEO らが共同議長

「To Err Is Human」(2000年の画期的報告書)の遺産を継承
AIを活用した「ゼロハーム」国家戦略を策定中

ECRI (米国医療安全研究機構) が「警告」を出し、NAM が「戦略」を立てる。
「光と影」のその先に、「制度設計」が始まっている。

安全に使うための 4 ステップ

フレームワーク「知る→疑う→補完→伝える」

(1) 知る

この AI は何で
評価された？

(2) 疑う

自分の判断と
照合する

(3) 補完

AI+ 人間の
強みを組み合わせ

(4) 伝える

患者に
透明性を保つ

[!] AI の答えを鵜呑みにしない。常に自分の臨床判断と照合する。

倫理の空洞 -- 誰が監視するのか

- AMA = American Medical Association（米国医師会）が倫理ジャーナルを廃刊
- 同時に AI センターを設立 -- 「倫理」より「実装」を優先する姿勢
- IC = Informed Consent（インフォームドコンセント：説明と同意）に AI 使用を含めるべきか未定
- VC = Venture Capital（ベンチャーキャピタル：投資ファンド）が医療 AI 市場に大量資金投入
- 「誰のための AI か」が問われている -- 患者か、効率化か、投資家か

テクノロジーの進歩に、倫理的議論が追いついていない。
だからこそ、現場の医師が考える必要がある。

ディスカッション

4 分間 → 全体共有 2 分

あなたが AI を使って「助かった」経験と
「危なかった」経験は？
その違いは何だったか？

考えるヒント

- AI の答えをそのまま使ったことはあるか？
- 患者に AI 使用を伝えたことはあるか？
- AI の間違いに気づいた経験はあるか？

持ち帰り

来週までの 1 アクション

- 自分が使っている（または使おうとしている）AIの「評価方法」を調べる
- 同僚と「AIの答えが自分の判断と違った経験」を共有
- 「パジャマタイム」がどれくらいあるか、自分で計測してみる

医師の 94% が使っているのに、
「どう安全に使うか」を議論している人はほとんどいない。

それを議論できるあなたは、もう一歩先にいる。